

# Tự thông tiểu ngắt quãng (ISC)

Thông tin cho bệnh nhân · Tự làm trống bàng quang bằng ống thông mỏng

WARWIKI

Tự thông tiểu ngắt quãng (ISC) là cách làm trống bàng quang bằng cách nhẹ nhàng đưa một ống thông mỏng, mềm vào tự mình, dẫn nước tiểu ra rồi rút ống — thực hiện vài lần mỗi ngày. Phương pháp này dùng khi bàng quang không tự làm trống hoàn toàn. Sau khi học, mỗi lần chỉ mất vài phút, giúp bạn tự do sinh hoạt và bảo vệ thận.

## Tại Sao Cần Làm

Nếu bàng quang không thể làm trống hoàn toàn — sau một số phẫu thuật, do **bàng quang thần kinh**, sa tạng chậu, hoặc tắc nghẽn — nước tiểu tồn đọng có thể gây nhiễm trùng, tiểu không kiểm soát, và áp lực làm hại thận. ISC **làm trống bàng quang hoàn toàn** theo lịch, giải quyết các vấn đề này.

## Ưu Điểm so với Ống Thông Lưu

- **Ít nhiễm trùng hơn** so với ống thông lưu (để trong liên tục)
- **Không có túi**, tự do hơn — không có gì gắn vào giữa các lần thông tiểu
- Bảo vệ bàng quang và thận tốt hơn về lâu dài

Lúc đầu có vẻ khó, nhưng hầu hết mọi người — và người chăm sóc — học nhanh với sự hướng dẫn của điều dưỡng.

## GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ

### ISC

Tự thông tiểu ngắt quãng — tự làm trống bàng quang rồi rút ống thông ra.

### Ống thông

Ống mỏng, mềm đưa vào bàng quang để dẫn nước tiểu ra.

### Nước tiểu tồn dư

Lượng nước tiểu còn lại trong bàng quang sau khi đi tiểu.

### Bàng quang thần kinh

Bàng quang hoạt động bất thường do rối loạn thần kinh.

### Kỹ thuật sạch

Rửa tay và vùng thông tiểu — sạch, không cần vô trùng hoàn toàn.

### Ống thông lưu

Ống thông để lại bên trong kèm túi chứa (điều mà ISC giúp tránh).

**CÓ ĐAU KHÔNG?** Thường không — hầu hết mọi người chỉ cảm thấy hơi căng tức nhẹ; ống thông hiện đại đã được bôi trơn sẵn và rất mỏng. Có thể hơi khó chịu hoặc có chút rỉ máu nhỏ trong những lần đầu. Điều dưỡng sẽ hướng dẫn từng bước cho đến khi bạn tự làm được.

## Cách Thực Hiện (Kỹ thuật sạch)

- 1 **Rửa tay** và chuẩn bị dụng cụ; làm sạch miệng niệu đạo.
- 2 **Nhẹ nhàng đưa** ống thông đã bôi trơn vào cho đến khi nước tiểu chảy ra; đưa thêm một chút.
- 3 Để bàng quang **làm trống hoàn toàn**, sau đó rút ống thông ra từ từ.
- 4 **Bỏ ống thông** dùng một lần (hoặc vệ sinh ống dùng nhiều lần theo hướng dẫn) rồi rửa tay.

## Tần Suất

- Thường **mỗi 4–6 giờ** (khoảng 4–6 lần mỗi ngày) — nhóm chăm sóc sẽ đặt lịch cho bạn.
- Không bỏ qua — lịch đều đặn ngăn bàng quang quá đầy và ngừa nhiễm trùng.
- Uống nước bình thường; ghi lại lượng nước tiểu nếu được yêu cầu.

## Cần Biết Thêm

- Có thể thực hiện ở bất kỳ nhà vệ sinh sạch nào; dụng cụ nhỏ gọn, dễ mang theo.
- Nước tiểu hơi đục hoặc có vi khuẩn là điều thường gặp — chỉ điều trị nhiễm trùng đường tiết niệu (UTI) khi có **triệu chứng**.
- Người chăm sóc có thể được hướng dẫn nếu bạn không tự thực hiện được.

### Hãy gọi cho nhóm chăm sóc nếu bạn có:

- **Không thể đưa ống thông vào**, hoặc ra rất ít/không có nước tiểu nhưng cảm thấy căng tức
- Sốt, ớn lạnh, hoặc đau lưng/hông (có thể nhiễm trùng)
- **Chảy máu** kéo dài hoặc đau nhiều

## BA ĐIỀU CẦN NHỚ

1. ISC làm trống bàng quang khi bàng quang không tự làm được — bảo vệ thận và ngừa nhiễm trùng, tiểu không kiểm soát.
2. Dùng kỹ thuật sạch theo lịch đều đặn (thường mỗi 4–6 giờ); điều dưỡng sẽ hướng dẫn cho đến khi bạn thành thạo.
3. Thường không đau và an toàn hơn ống thông lưu. Gọi ngay nếu không đưa được ống vào, không làm trống được, hoặc bị sốt.